

Manejo de citologías anormales

1. Introducción y relevancia clínica

El **Papanicolaou (PAP)** es la herramienta de tamizaje más usada en Chile para la detección de **lesiones cervicales premalignas** causadas por el **Virus del Papiloma Humano (VPH)**.

Sin embargo, cuando el resultado del PAP es **anormal**, el desafío clínico radica en **determinar la conducta adecuada**: observar, repetir, realizar colposcopia o tratar.

El **MINSAL (Norma Técnica de Cáncer Cervicouterino 2023)** establece protocolos claros según la clasificación **Bethesda 2014**, que permiten estandarizar la atención y evitar tanto **subtratamiento** (riesgo de progresión) como **sobretratamiento** (riesgo de infertilidad cervical o parto prematuro).

- ❑ En EUNACOM es clásico que te den un resultado citológico ("PAP con LSIL en mujer de 32 años") y te pidan la conducta más adecuada.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

- La mayoría de las **lesiones cervicales** son causadas por infección persistente por **VPH de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)**.
- La progresión hacia **neoplasia intraepitelial cervical (NIC)** es lenta, ofreciendo una amplia oportunidad para detección y tratamiento.
- La **citología** detecta cambios morfológicos, mientras que el **test VPH** identifica la presencia viral antes de las alteraciones celulares.

La clave del manejo es **equilibrar vigilancia y tratamiento**, evitando intervenciones innecesarias en lesiones de bajo grado que pueden **regresar espontáneamente**, especialmente en mujeres jóvenes.

3. Clasificación citológica Bethesda (2014)

Categoría	Descripción	Posible correlato histológico
Negativo para lesión intraepitelial o malignidad	Normal	Sin lesión
ASC-US	Células escamosas atípicas de significado incierto	Lesión leve o inflamatoria
ASC-H	Atipias donde no puede excluirse HSIL	Lesión moderada o severa
LSIL	Lesión escamosa de bajo grado	NIC I
HSIL	Lesión escamosa de alto grado	NIC II o III
AGC / AIS	Células glandulares atípicas o adenocarcinoma in situ	Riesgo de adenocarcinoma

4. Manejo clínico según tipo de lesión (según MINSAL 2023)

A continuación se presentan las conductas específicas **por grupo citológico**.

A.

ASC-US (células escamosas atípicas de significado incierto)

1. Definición

Alteraciones leves, frecuentemente por inflamación o infección transitoria por VPH.

Representan el 2–5% de los PAP.

2. Conducta

Edad	Conducta	Justificación
<30 años	Repetir PAP en 12 meses	Alta tasa de regresión espontánea
≥30 años	Realizar test de VPH	Si positivo → colposcopía; si negativo → control rutinario
Embarazo	Repetir PAP posparto	No realizar colposcopía durante gestación si no hay sospecha de HSIL

☐ Si el test VPH es positivo para genotipos 16 o 18 → colposcopía inmediata.

B.

ASC-H (atipias que no descartan HSIL)

1. Definición

Cambios más marcados que ASC-US, con sospecha de lesión de alto grado.

2. Conducta

- **Colposcopía inmediata**, independientemente de la edad.
 - Si colposcopía no concluyente → **biopsia o conización diagnóstica**.
-

C.

LSIL (lesión escamosa intraepitelial de bajo grado)

1. Definición

Cambios celulares leves compatibles con infección por VPH o NIC I.

2. Conducta

Edad	Conducta
<30 años	Colposcopia inmediata (preferible) o repetir PAP en 12 meses
≥30 años	Test de VPH o colposcopia directa
Si colposcopia normal y VPH negativo	Control en 12 meses
Si colposcopia anormal o VPH positivo	Biopsia dirigida
En embarazadas: observar y posponer tratamiento hasta posparto, salvo sospecha de invasión.	

D.

HSIL (lesión escamosa de alto grado)

1. Definición

Cambios compatibles con NIC II o III; alto riesgo de progresión a cáncer invasor.

2. Conducta

- **Colposcopia y biopsia inmediata.**
- Si colposcopia no concluyente → **conización diagnóstica y terapéutica.**
- Si histología confirma NIC II o III → **tratamiento ablativo o excisional (LEEP, conización).**

□ En mujeres jóvenes (<25 años) puede considerarse manejo conservador si NIC II confirmado y alta adherencia a seguimiento.

E.

AGC (células glandulares atípicas) / AIS (adenocarcinoma in situ)

Conducta

- **Colposcopia + legrado endocervical + biopsia dirigida.**
 - Si se sospecha AIS o adenocarcinoma → **conización diagnóstica.**
 - Si resultado confirma AIS → **histerectomía simple** (si no desea fertilidad).
-

F.

Lesiones malignas (carcinoma epidermoide o adenocarcinoma invasor)

Conducta

- **Derivar de inmediato a ginecología oncológica.**
 - Realizar estudio de extensión y etapificación (FIGO).
 - Manejo con cirugía radical o radioterapia según etapa.
-

5. Manejo post-tratamiento

Tipo de lesión tratada	Control recomendado
NIC I / LSIL	PAP o test VPH a los 12 meses
NIC II–III / HSIL	Test VPH a los 6 y 12 meses
AIS / carcinoma	Control en unidad oncológica

**Si test VPH negativo a 1
año**

Retorna a tamizaje rutinario

6. Conducta en situaciones especiales

a.

Embarazo

- No realizar conización ni legrado.
- Solo colposcopía si HSIL o sospecha de invasión.
- Control posparto con PAP + VPH.

b.

Menores de 25 años

- Mayor probabilidad de regresión espontánea.
- Conducta conservadora con vigilancia anual.

c.

Inmunocomprometidas (VIH, trasplante)

- Mayor riesgo de persistencia y progresión.
- **PAP anual** y colposcopía ante cualquier anormalidad.

7. Integración del test VPH al manejo citológico

Resultado combinado

Conducta

PAP normal + VPH negativo Control rutinario (5 años)

PAP normal + VPH positivo Repetir test o
colposcopía

PAP anormal + VPH positivo Colposcopía inmediata

PAP anormal + VPH negativo Repetir PAP en 12
meses

En mujeres >30 años, el **co-test (PAP + VPH)** es el método de mayor rendimiento diagnóstico.

8. Comunicación y seguimiento

El **seguimiento adecuado** y la **educación de la paciente** son tan importantes como el tratamiento:

- Explicar significado de los resultados.
 - Reforzar que una citología anormal **no equivale a cáncer**.
 - Garantizar seguimiento y registro en ficha clínica.
 - Ofrecer consejería sobre **VPH, ITS y vacunación**.
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **ASC-US:** repetir PAP o test VPH; si positivo → colposcopía.
2. **LSIL:** colposcopía inmediata, especialmente ≥30 años.

3. **HSIL:** colposcopía + biopsia o conización diagnóstica.
4. **AGC / AIS:** colposcopía + legrado endocervical.
5. En **embarazo:** solo vigilancia, posponer tratamiento.
6. **Test VPH negativo post-tratamiento = curación.**
7. Control estricto y registro en programa MINSAL.



Errores comunes

- Tratar ASC-US o LSIL con cirugía inmediata.
- No realizar colposcopía ante HSIL.
- Interpretar “VPH positivo” como cáncer.
- No seguir protocolos de control post-tratamiento.
- Olvidar derivar AGC a especialista.
- Descartar seguimiento en menores de 25 años con LSIL (aun necesitan control).

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **manejo de citologías anormales** se basa en la clasificación Bethesda.
2. **ASC-US:** repetir PAP o test VPH.
3. **LSIL:** colposcopía inmediata.
4. **HSIL:** colposcopía + biopsia / conización.
5. **AGC / AIS:** estudio colposcópico y canal endocervical.
6. En **embarazo:** observación y seguimiento posparto.
7. La **confirmación histológica y el seguimiento** son claves para evitar progresión a cáncer.